

INDICADO POR: Dr. Alberto Remesar

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 22231570294 | 715

VIVIANE HERICA SILVA VIEIRA

IDADE: 50 PESO: 82 ALTURA: 1,65 PROFISSÃO: Consultora

SINTOMAS: Sonnia Sonolencia diurna cansaço
chegada a dormir ao despertar

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Desvufenazina 100mg / Zolpidem 5mg
Amitil

MÉDICO: Dr. Alberto Remesar

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: não realiza

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: — JANTAR: 19h

HORA QUE DORME: 1h HORA QUE ACORDA: 7:30-8h

COCHILHO () S (X) N DORME ACOMPANHADO: () S (X) N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S (X) N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 2x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 65,6cm SPO2: 75%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: AVC hemorrágico (2016) / Relata atrofia
pulmonar para SI diagnóstico fechado

CIRURGIAS: (S) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(X) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: (X) S () N SPO2 CI/CPAP: 76% PRESSÃO NO EXAME: 100cmH2O

13/12/24 Avaliação máscara Wisp trica (S/N)

19/12 P= 10,8 Natacha

24 IAH= 4,2 falar q Dr. Alberto.
M. de uso: 6h14' sua
fuga: 17lpm.

06/01/2025 P= 10,8 cmH2O mto escape bocca

IAH= 5,4 x 1h
muro: 5h40min P= 10,4 cmH2O
fuga: 30l/min

→ fazendo caminhada
silenc

20/01 P= 10,4 cmH2O

25 IAH= 2,3 ejet 1 hora caminhada

M. de uso: 6h42'
fuga: 27,2 lpm.

sua.

10/02 P=10.4cmHg O (21/20 = 7h14')

25 IAH=3.7.

m. de uso: 7h14'

fuga= 28 epm.

- Lugabalina

- Amitril

- Rivotril 5 gts.

compro o CPAP sua



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Viviane Herica Silva Vieira

EXAME nº: 5587-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

DATA: 10/06/2024

IDADE: 49 anos

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

Comentários:

Exame iniciado às 23h58min e concluído às 06h03min. A latência para o sono foi de 10 minutos e a latência para o estágio REM, de 165 minutos. O tempo total de sono foi de 320 minutos (05h20min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 89,1%. A distribuição do sono mostrou 20,2% de estágio 1, 50,3% de estágio 2, 26,6% de estágio 3 e 3% de sono REM. No período total de sono permaneceu 28,5 minutos em vigília, ocorreram 129 microdespertares (índice: 24,2/hora).

O índice de movimentos dos membros inferiores foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 13,9/hora, sendo 3,8 apneia/hora e 10,1 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 13,9/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 96%, sendo a média de 93% e a mínima de 76%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono

TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

A paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ela usou a máscara nasal Mirage Activa medium (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 10,8 cm de H₂O.

Registraram-se aumentos leves dos índices de apneia/hipopneia (13,9/hora; índice leve: 5 a 15/hora) e de distúrbio respiratório (13,9/hora), ritmo cardíaco sinusal, despertares e alguns episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina. As frequências cardíacas foram: mínima: 54; máxima: 83 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

A paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 10 min; normal até 30 min) – ela usou um comprimido de Patz 5 mg às 23h55min. A latência para o estágio REM estava alongada (165 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono (89,1%; normal: 85% ou acima) permanecer no limite da normalidade, o sono foi fragmentado microdespertares (índice: 24,2/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (20,2%; normal: 8-10%) e 3 (26,6%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (3%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (50,3%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Avenida Dr. João Guilhermino, 474, sl 51 e 52

Ed. Office Tower - Centro - São José dos Campos

Tel: (12) 3913-2162 | (12) 3941-2449 | (12) 99622-8008

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69730



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

Solicito o aluguel ou venda do
CPAP para a Sra. Viviane Hérica Silva
vieira, pois tem a síndrome da apnéia
do sono.

Ela usou a máscara nasal e
a pressão recomendada foi de 10,8 cmH₂O.

Diagn: G47.3

Attl,

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730

SJC, 7/10/24

Avenida Dr. João Guilhermino, 474, sl 51 e 52
Ed. Office Tower - Centro - São José dos Campos
Tel: (12) 3913-2162 | (12) 3941-2449 | (12) 99622-8008